

Management of Patient with Arteriosclerosis and Atherosclerosis

إدارة مريض تصلب الشرايين وتصلب العصيدة

1) Introduction – المقدمة

Arteriosclerosis and Atherosclerosis are diseases that affect the arteries and reduce blood flow.

تصلب الشرايين وتصلب العصيدة هما أمراض تؤثر على الشرايين وتقلل تدفق الدم.

They cause thickening, hardening, and reduced elasticity of vessel walls.

تسبب هذه الأمراض زيادة سُمك الشريان وتصلبه وفقدان مرونته.

2) Arteriosclerosis – تصلب الشرايين

Arteriosclerosis is a general term for age-related thickening and hardening of small arteries.

تصلب الشرايين هو مصطلح عام للتغيرات التي تحدث في شرايين الجسم مع التقدم في العمر.

The artery wall becomes thick due to calcium deposits.

جدار الشريان يصبح سميكًا بسبب ترسب الكالسيوم.

The vessels lose elasticity and the lumen becomes narrower.

تفقد الأوعية مرونتها ويضيق التجويف الداخلي للشريان.

Reduced blood flow may lead to ischemia and tissue necrosis.

نقص تدفق الدم ممكن يؤدي لنقص الأكسجين وموت الأنسجة.

Uncontrolled diabetes and hypertension accelerate arteriosclerosis.

السكر غير المنتظم والضغط العالي يسرعون حدوث تصلب الشرايين.

3) Atherosclerosis – تصلب العصيدة (تضييق الشرايين)

Atherosclerosis is a chronic condition caused by fatty plaque buildup inside arteries.

تصلب العصيدة هو حالة مزمنة ناتجة عن تراكم الدهون داخل جدران الشرايين.

Plaques cause thickening, hardening, and narrowing of arteries.

اللويحات تسبب سُمكًا وتصلبًا وتضيّقًا في الشرايين.

It increases the risk of heart disease, stroke, and peripheral artery disease.

يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

Pathophysiology – آلية المرض

Lipids collect inside the vessel wall and combine with cells and fibrin to form plaque.

تتجمع الدهون داخل جدار الشريان وتختلط بالخلايا والفيبرين لتكوين اللويحة.

The plaque grows and narrows the artery lumen.

اللويحة تكبر وتسد تجويف الشريان.

Inflammation can expose plaque contents to blood → clot formation.

الالتهاب يمكن أن يعرّض اللويحة للدم فيحدث تجلّط.

4) Risk Factors – عوامل الخطر

High LDL cholesterol

ارتفاع الكوليسترول الضار.

Hypertension

ارتفاع ضغط الدم.

Smoking

التدخين.

Diabetes mellitus

مرض السكر.

Obesity & sedentary lifestyle

السمنة وقلة الحركة.

Unhealthy diet high in fats

نظام غذائي مليء بالدهون الضارة

Age and family history

العمر والتاريخ العائلي

Chronic inflammation

التهابات مزمنة

5) Clinical Manifestations – العلامات والأعراض

Symptoms depend on the artery affected.

الأعراض تعتمد على المكان المصاب

Coronary arteries – شرايين القلب

Chest pain, shortness of breath, fatigue.

ألم صدر، ضيق نفس، تعب

Carotid arteries – شرايين الرقبة

Weakness, numbness, speech difficulty, vision problems.

ضعف مفاجئ، تنميل، صعوبة كلام، مشاكل رؤية

Peripheral arteries – شرايين الأطراف

Leg pain while walking (claudication), cold feet.

ألم في الساق أثناء المشي، برودة الأطراف

Severe cases can cause heart attack or stroke.

الحالات الشديدة قد تسبب جلطة قلبية أو دماغية

6) Complications – المضاعفات

Heart attack

.جلطة قلبية

Stroke

.جلطة دماغية

Peripheral artery disease

.مرض الشرايين الطرفية

Kidney damage

.تلف الكلى

7) Diagnosis – التشخيص

Lipid profile test

.تحليل دهون الدم

Blood pressure measurement

.قياس ضغط الدم

Doppler or ultrasound for arteries

.دوبلر أو أشعة موجات فوق صوتية على الشرايين

ECG / Echocardiography

.رسم قلب / موجات فوق صوتية للقلب

8) Treatment – العلاج

1) Lifestyle Modifications – تغييرات نمط الحياة

Healthy diet low in fats and salt.

.أكل صحي قليل الدهون والملح

Regular exercise.

رياضة منتظمة

Quit smoking.

التوقف عن التدخين

Control diabetes & blood pressure.

تنظيم السكر والضغط

2) Medications – الأدوية

Statins → lower cholesterol.

الستاتين: تقلل الكوليسترول

Antihypertensives → control BP.

أدوية الضغط

Antiplatelets (e.g., aspirin) → prevent clots.

مضادات الصفائح مثل الأسبرين لمنع الجلطات

Diabetes medications.

أدوية السكر

3) Surgical Management – التدخل الجراحي

Angioplasty with stent.

قسطرة ووضع دعامة

Coronary artery bypass (CABG).

جراحة تحويل مسار شرايين القلب

9) Nursing Care – الرعاية التمريضية

Monitor vital signs and pulses.

مراقبة العلامات الحيوية والنبض.

Assess extremities for color, warmth, and sensation.

فحص الأطراف للون والحرارة والإحساس.

Encourage diet and exercise modifications.

تشجيع المريض على الأكل الصحي والرياضة.

Educate patient about medications.

تثقيف المريض حول الأدوية.

Monitor for signs of complications (chest pain, numbness, cold limbs).

متابعة علامات المضاعفات مثل ألم الصدر وتنميل أو برودة الأطراف.

تشخيصات تمريضية – 10) Nursing Diagnoses

Ineffective tissue perfusion.

قصور في تروية الأنسجة.

Risk for decreased cardiac output.

خطر انخفاض النتاج القلبي.

Activity intolerance.

عدم تحمل النشاط.

Imbalanced nutrition (more than body needs).

غذاء غير متوازن.

Risk for ineffective health management.

خطر سوء إدارة الصحة.

Anxiety.

قلق.